PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

1. Las 10 preguntas iniciales

Pregunta 1: ¿Cómo cambió la cantidad total de casos de infecciones respiratorias agudas en la etapa post pandemia (2025) respecto de la etapa pre pandemia (2019)?

Pregunta 2: ¿Qué eventos (enfermedad tipo influenza, neumonía y bronquiolitis) aumentaron y cuáles disminuyeron entre 2019 y 2025?

Pregunta 3: ¿Cambió la estacionalidad de las infecciones respiratorias? ¿El pico de casos ocurre en las mismas semanas epidemiológicas en 2019, 2025 y 2026?

Pregunta 4: ¿Cambió la distribución de los casos por grupo de edad entre la etapa pre pandemia y la post pandemia?

Pregunta 5: ¿Qué provincias presentan mayor incidencia relativa de casos respiratorios en relación a su población, y cómo cambió esa incidencia entre 2019 y 2025?

Pregunta 6: ¿Cómo cambió la bronquiolitis en menores de 2 años entre 2019 y 2025, y en qué semanas se concentra en cada período?

Pregunta 7: ¿Qué cambios entre 2019 y 2025 podrían deberse a modificaciones en la forma de notificar los casos y no a cambios reales en la enfermedad?

Pregunta 8: ¿Los datos de 2026 (semanas 1 a 36) confirman los cambios observados en 2025 respecto de 2019?

Pregunta 9: ¿Qué grupos de edad muestran mayor aumento o disminución de casos de enfermedad tipo influenza entre 2019 y 2025?

Pregunta 10: ¿Cómo cambió la proporción de casos sin edad especificada entre 2019 y 2025, como indicador de calidad del registro?

2. Selección de preguntas para el análisis

A partir de las 10 preguntas iniciales, el equipo deberá seleccionar **3 preguntas** que considere más relevantes y que puedan ser abordadas utilizando los datos disponibles.

Preguntas seleccionadas:

1. **Pregunta principal: ¿Qué eventos (enfermedad tipo influenza, neumonía y bronquiolitis) aumentaron y cuáles disminuyeron entre 2019 y 2025?**
2. ¿Cambió la estacionalidad de las infecciones respiratorias? ¿El pico de casos ocurre en las mismas semanas epidemiológicas en 2019, 2025 y 2026?
3. ¿Qué provincias presentan mayor incidencia relativa de casos respiratorios en relación a su población, y cómo cambió esa incidencia entre 2019 y 2025?

3. Justificación de la selección

Pregunta principal: cambios por tipo de evento (análisis de comparación). Es la pregunta que mejor resume el foco del proyecto: describir cómo cambiaron las infecciones respiratorias después del COVID-19. Se comparan 2019 (último año completo pre pandemia) y 2025 (último año completo disponible), en las mismas semanas

epidemiológicas. Una primera exploración muestra que los cambios no van en la misma dirección: la enfermedad tipo influenza aumentó alrededor de un 45%, la neumonía se mantuvo estable (+6%) y la bronquiolitis disminuyó cerca de un 37%. Se espera describir y dimensionar estos cambios. Para compararlos se unificarán las categorías de evento, porque en 2025 neumonía y bronquiolitis se informan separadas en ambulatorio, internado y sin especificar, y en 2019 no.

Cambio en la estacionalidad (análisis de evolución). Permite ver si cambió el momento del año en que se concentran los casos. En la exploración inicial, el pico de enfermedad tipo influenza se ubicó en la semana 28 en 2019, en la 24 en 2025 y en la 21 en 2026, lo que sugiere un adelantamiento de la temporada que se analizará con las curvas semanales superpuestas. Incluir 2026 (semanas 1 a 36) permite ver si el patrón se repite.

Incidencia por población y su cambio por provincia (análisis de comparación territorial). Comparar cantidades absolutas entre provincias distorsiona el análisis, porque Buenos Aires concentra más de un tercio de los casos al ser la más poblada. Por eso se calculará la tasa cada 100.000 habitantes (población del Censo 2022, INDEC) para 2019 y 2025, y se identificarán las provincias con mayor incidencia y mayor cambio. Al interpretar se considerará el posible subregistro: Santa Fe pasó de 26.742 casos notificados en 2019 a 2.550 en 2025, una caída que probablemente se explique por cambios en la notificación y no en la enfermedad.

En conjunto, las tres preguntas abordan el cambio pre pandemia/post pandemia desde tres dimensiones complementarias (qué cambió, cuándo y dónde) y se responden con variables completas de ambos datasets. El análisis será descriptivo: los datos permiten observar cambios, pero no atribuirlos exclusivamente a la pandemia, porque en el período también cambiaron los sistemas de notificación y otros factores externos. Las preguntas sobre grupos de edad y calidad del registro quedan como líneas para los próximos Sprints.